

1장. 산후병의 개술

1. 산후병의 개술

1) 산후병의 정의

- 신산(新産) 후나 산욕기에 산모에게 발생하는 분만이나 산욕과 관련된 질병
- 신산후 : [고대] 산후 1개월 내 | [최근] 분만 후 7일 이내
- 산욕기 : 태아, 태반 및 그 부속물이 만출 후에 생식기관이 비임신 상태로 회복되는데 필요한 일정한 시간 (대략 6-8주)
[한의학] 산후 100일 이내(百日爲度)

2) 산후병의 특징(반드시 기억)

- ① 다허(多虛) : 분만 중 용력과다. 산도손상으로 인한 출혈
→ 원기손상, 기혈부족 → 百脈이 공허하게 되어 허증
- ② 다어(多瘀) : 산후 포궁이 정상으로 회복되는 과정 중 어혈이 쉽게 정체
→ 포궁에 응체되고 구혈(舊血)이 제거되지 못함 → 어혈
- ③ 이한(易寒) : 쉽게 차가워짐
- ④ 이열(易熱) : 쉽게 더워짐

3) 산후위증

- 산후의 위중한 병을 삼병(三病), 삼충(三衝), 삼급(三急)으로 개괄

신산삼병 新産三病	① 산후병경(産後病瘕) • 産後血虛 多汗出 喜中風 故病瘕 → 筋病 ② 울모(鬱冒) • 新産亡血復汗 多汗 故病鬱冒 → 神病 ③ 대변난(大便難) • 新産亡津液 胃燥 故大便難 → 液病
산후삼충 産後三衝	- 어혈이 상충하여 발생하는 일종의 위급증 ① 패혈충심(敗血衝心) ② 패혈충폐(敗血衝肺) ③ 패혈충위(敗血衝胃)
산후삼급 産後三急	- 진액손상이 가중되고 음혈이 상해 양기가 쉽게 허탈됨 ① 구토 ② 설사 ③ 도한

2. 산후병의 발병기전

- ① 분만시 충·임·포맥 손상, 출혈 과다하여 망혈상진(亡血傷津)
- ② 어혈내조해 氣機不利하면 구혈이 포궁을 조체 패혈이 망행
- ③ 정기 虛하여 사기 침범, 육음 감수, 음식부절, 방로로 인해 영위불조, 기혈불화가 일어나 장부기능손상

3. 산후병의 진단

- 산후병의 임상과정에서는 三審과 분만시의 상황, 산모의 체질과 증상, 맥설 등을 결합하여 분석 및 진단
- 산전 / 산후의 병력 또한 확인해야함

※ 産後三審

- ① 先審 小腹痛與不痛 : 아랫배의 통증으로 오로의 유무 판단
- ② 次審 大便通與不通 : 대변의 유무로 진액의 성쇠 판단
- ③ 再審 乳汁行與不行及飲食多少 : 유즙이 잘 나오는지, 음식을 잘먹는지를 통해 위기의 강약을 판단

※ 산후통용방

- 대보기혈 : 팔진탕, 귀비탕, 당귀작약탕, 보허탕
- 보기혈활혈 : 생화탕, 실소산
- 활혈화어 : 계지복령환
- 산후하태방 : 평위산 가 망초

4. 산후병의 치료

- *勿拘于産後 亦勿忘于産後의 치료 원칙에 따라 扶正祛邪化瘀法 위주로 실시
- 산후에 너무 구애받지 말고 또 산후라는 것 역시 잊어버리지 마라
- 과하지 않으며 기혈을 고려한 치료를 시행하는 것을 중요하게 생각함
Ex. 청열 시 한량이 과하지 않게, 발산 시 온조가 과하지 않게...

※ 産後三禁(산후삼금)

- ① 금한(禁汗) 가장 조심해야 할 것 (망양상기), 절대적 금기
- ② 금하(禁下) (망음상혈)
- ③ 금리소변(禁利小便) 과한 리소변만 피하자 (진액손상)

- 최근 의학에서는 수액요법이 생겨나 전해질 조절이 가능해짐
- 따라서, 통리소변이 절대적 금기는 아님, 융통성 있는 사용이 가능함

※ 참고

- ① 불수산 : 천궁의 발한작용을 염려
- ② 사물탕 : 숙지황의 사하작용을 염려
- ③ 소시호탕 : 황금의 오로조애(惡露阻滯)를 염려
 - 위 세 처방은 고방의 三禁
- ① 血脫 (産後崩漏) → 형지지봉탕, 가삼생화탕, 당귀보혈탕, 정원음
- ② 氣脫 (産後氣喘) → 독삼탕, 거원전, 대보회양생화탕
- ③ 神脫 (産後妄言發狂, 狂言譫語) → 영신생화탕, 팔진탕, 안신생화탕
- ④ 汗脫 (産後自汗, 産後汗出不止) → 기부탕
 - 위 세 처방은 산후위급중증 처방

2장 산후오로관련병증

1절 산후 오로부절

1. 개술

1) 산후 오로부절의 정의

- 산후에 오로가 3주일을 초과해도 조금씩 흐르며 멎지 않는 경우
- “만기 산후출혈” 및 “자궁 복구부전”과 유사

2) 지속기간

- 분만 후 평균 4주 지속 (8주까지 간헐적)
 - └ 평균 27일 11%의 산모에서는 40일 이상 지속
- 산모의 연령, 산과력, 신생아 체중, 모유수유에는 영향 X
- 유전성 출혈 이상 소인이 있는 여성은 정상여성에 비하여 평균지속 기간 길

3) 경과

- 출산 후 1주에 태반부착부위 혈류 증가하여 6주간에 걸쳐 점차 사라짐
- 간혹 분만 7-14일에 자궁출혈 증가하지만 일시적이며 처치 없이 저절로 멈춤
 - └ 다만, 1-2시간 이상 멈추지 않으면 잔류태반 등의 산후출혈원인을 의심

4) 치료

- 옥시토신 등 자궁수축제 먼저 사용 → 교정되지 않거나 재발 시 소파술
- 치료적 소파술을 우선 시행시 태반부착부 손상을 일으킬 수 있음

2. 병인병기

- 한의학 : 충임맥 不固, 산후 精志不暢 → 기울혈어 → 어혈이 충임맥 阻塞 → 포궁 수축력 회복 이상 → 오로부절
- 현대의학 : 태반이나 태반편의 잔류(40%), 회음절개부위 혈종, 임신성 고혈압

및 팽창된 자궁, 골반강 감염이나 산후에 자궁의 복구가 불량하여 산욕만의 출혈이 발생

3. 진단과 감별진단

- 1) 임상증상 : 오로 4주일 이상 지속되고 깨끗하지 못하며, 양이 많거나 조금씩 흐르며 멎지 않고 색·질·기미 이상하며 복통과 전신증상을 수반
- 2) 검사소견 : 체온 정상, 자궁체부는 정상적 산욕기 자궁에 비해 비교적 크고 연하며 혹은 압통이 있다
- 3) 감별 : 산후혈붕, 산후발열

4. 치료

- 오로의 양·색·질·기미의 변화에 따라 허실한열로 변증
- 복통 수반 여부와 결부시켜서 변증치료
- 調理氣血, 固攝衝任 위주로 치료
- 虛則補之 瘀則行之 熱則清之의 원칙

∴ 오로부절의 치료에는 多虛, 多瘀한 부인의 특성을 잊지 말아야 함
補虛하되 不留瘀하고 祛瘀하되 不傷正해야한다.

기허형	오로 양 많음, 담홍색, 淸稀하고 臭氣 없음, 소복이 내려앉음	
	고섭충임	보중익기탕, 당귀생강양육탕, 거원전
혈열형	오로 양 많음, 선홍색·자홍색, 臭氣 있고 복통수반	
	양음, 청열, 지혈	보음전, 양지탕
혈어형	오로의 양이 적음, 或多或少, 자암색, 혈괴 있고 복통 있음	
	화어지혈	생화탕, 불수산 합 실소산

2절 산후 오로불하

1. 개술

정의	- 태반 만출 후 포궁 내 남아있는 혈이 정체하여 전혀 나오지 않거나 소량만이 나오며 소복동통 동반하는 경우
증상	① 혈이 역상 - 두통, 목현, 오심구토, 혼궤 ② 어혈이 경락에 유주 - 지절종통, 마목중착(麻木重着)
발병기전	- 산후오로불하는 氣滯,血瘀,血虛로 발생 ① 간기울결로 소설기능이 不及, 氣滯 → 血行不暢 ② 혈이 한을 만나 응체되어 오로가 內停 ③ 분만으로 더욱 허약해졌거나 분만 시 失血 과다

2. 치료

- 實者瀉之,虛者補之의 원칙
- 실한 경우는 活血行瘀, 허한 경우는 補養氣血위주

기체형	홍협창만, 정신억울	
	이기해울 좌이활혈	향애궁귀음
혈어형	오로색자암, 소복동통, 거안, 혈괴 축지	
	활혈행어	생화탕
혈허형	오로색담, 소복은통, 면백, 두훈, 이명, 심계	
	양혈익기	성유탕

3절 아침통, 산후복통

1. 개술

정의	- 산후복통의 정의 : 분만 후부터 산욕기까지 소복동통이 주증인 것 : 분만 후 소복에 경미하게 진통이 있는 것 : 산후에 자궁의 수축이 회복되는 생리적인 현상 cf) 아침통 : 산후복통 중에서 어혈로 발생하는 경우' └ 실소산(포황 오령지) 기침산 궁귀탕(가 삼릉 봉출 현호색 목단피 도인 홍화)
특징	- 대개 생리적인 현상으로 점차 소실 → 처치 불필요 복통이 중하거나 은은하제 멎지 않으면 병리 → 처치 - 초산부는 분만 후 지속적 자궁수축으로 통증을 덜 느끼나 경산부는 주기적 자궁수축으로 심한 통증 호소 (다산일수록 심함) - 모유수유 중 심해짐(옥시토신), 분만 후 3일에는 통증 정도가 약해짐
병인병기	- 산후 오로배출의 곤란, 자궁의 빈번한 수축으로 발생
진단	- 분만 후 3~4일 이내 발생 - [임상증상] 하복부 강한 간헐적/은은한 통증, 오로 이상변화

2. 변증치료

혈허복통	소복은통, 복연(腹軟), 희안, 오로 양 적음	
	보혈익기	장영탕, 성유탕, 십전대보탕
혈어복통	소복동통 극렬, 거안, 오로 양이 적음 자암색, 혈괴가 있음, 홍협창만	
	활혈거어	생화탕 가 익모초, 산결정동탕, 향계산 합 실소산

3장 산후 감염과 발열

1절 산욕기감염

= 산욕이환 = 산욕열

- ☞ 산욕기 감염 : 분만 후에 생식기 감염이 생긴 것
- ☞ 산욕열 : 산욕기 중의 발열은 대부분 생식기 감염에 의한다

※ 참고

꼭 외부로부터의 감염이 아니더라도 제왕절개를 한 이후에 40일 정도 지나면 염증이 생기거나 분비물이 생겨 심하면 복막의 지방조직이 녹아 흘러내리기도 함, 이때에는 수술부위 발적이 있는지 등을 관찰해야한다.

1. 개술

정의	분만 후 생식기 감염으로 출산 후 첫 24시간을 제외한 10일 이내에 2일간 계속해서 1일 4번 구강으로 측정했을 때 체온이 38.0도 이상
원인	상기도감염, 유방울혈
특징	- 질식분만(20%)보다 제왕절개(70%) 후 많이 발생 - 첫 24시간 내 고열 원인균은 A·B 연쇄상구균 - 산모 3대 사망 원인 : 임신성 고혈압, 산과적 출혈, 산욕열 - 근래에는 예방적 항생제를 투여한다.

※ 골반 봉와직염

산욕기 감염으로 인한 후복막의 섬유륜성 골반 결체조직의 감염

- ① 감염된 경관 열상, 제왕절개 시 자궁 절개 부위 또는 자궁의 열상 부위에서부터 병원균의 임파선 전염에 의해 야기
- ② 자궁경관 열상의 직접 전파에 의해 광인대의 기저부 결체조직으로 파급되어 야기

③ 골반 정맥성 혈전염의 2차적 결과로 야기

2. 감별진단

골반감염	가장 흔함
유방울혈	15%, 24시간 이상 지속 X, 39도 이상 드묾 (참고) 유방에 울혈은 전신증상으로 이어지기도 함. 이는 유방 조직의 염증 소인이 전신적으로 퍼진 것
세균성 유방염	더 늦게 나타나고, 열이 더 오래 지속됨
호흡기감염	대부분 분만 이후 24시간 이내 발생, 대부분 제왕절개 관련
신우신염	발열, 세균뇨, 농뇨, 늑골척추각압통
혈전성 정맥염	산욕기에 발열 & 다리 붓는 경우 진단 (참고) 통증이 있으면서 다리가 부어오름 보통 장딴지 혹은 고관절 삼각부위에 통증이 있기도 함. 헤파린을 통해 치료한다.

※ 자궁감염

1) 개술

- 탈락막 뿐만 아니라 자궁근층, 자궁주위조직 등에 발생하므로 “골반조직염을 동반한 자궁염” 이 더 타당한 표현

2) 원인

- 가장 중요한 요인 : 분만경로 (제왕절개 > 질식분만)

3) 자궁감염의 고위험군

- 양막파수되고 진통을 오래한 경우 / 내진을 자주한 경우 / 자궁 내 태아 감시 장치

4) 세균학

- 주로 자궁경부, 질, 회음부의 정상 세균총에 의하여 태반착상부위, 분만시 절개 및 열상 부위에 감염
 └ 건강한 조직에는 감염 잘 일으키지 않고, 혈종이나 죽은 조직에 주로 감염

5) 임상증상

- 발열, 오한(균혈증), 복통 및 주위의 압통, 악취나는 분비물, 백혈구 증가
 └ 다만 생리적인 백혈구 증가와 감별하는 것이 쉽지 않음.

6) 치료

- (염증이 자궁에 국한 시 항생제 치료 없이 체온이 정상회복될 수 있으나) 빠른 치료를 위하여 항생제로 치료
 └ 경증 : 경구투여 / 중증도 이상 : 정맥주사
- 치료시작 시 90% 정도에서 48~72시간 이내 호전

7) 자궁감염의 합병증

- ❶ 창상감염 ❷ 복막염 ❸ 부속기 감염 ❹ 자궁주위 봉소염 ❺ 골반농양
 ❻ 패혈성 골반 혈전성 정맥염

2절 산후발열

1. 개술

정의	산욕기에 발열이 주증이거나 기타증상이 동반되는 것 └ 현대의학의 산후 체온상승을 의미하는 '산욕열'에 해당	
생리적 상태	① 산후 1~2일 내 경미한 발열, 다른 증상 X ② 증유(蒸乳) : 산후 3~4일 유즙분비기에 유방 딱딱, 팽창, 동통과 함께 체온 상승(대개 4~6시간)	
병인병기	- 산후 산모의 특징인 多虛, 多瘀와 관련 └ 혈허발열, 혈어발열 위주	
진단	임상증상	항상 오로에 이상, 소복통 수반
	감별진단	유옹, 산후이질발열, 산후임증발열, 산후장옹발열, 산후학질발열, 산후중서발열 └ 모두 오로 정상, 생식기관 이상 X

※ 산욕기 감염(이 파트에서 다시 언급됨)

- 산욕기 감염은 분만 후 여성 생식기의 세균 감염을 의미함.
- 전자간증, 산과적 출혈과 더불어 모성 3대 사망 요인
- 산욕기 이환이란 출산 후 첫 24시간을 제외한 10일 이내에 2일간 1일 4회 구강으로 측정된 체온이 38도 이상

2. 변증치료

감염사독	고열, 오한전율, 소복통, 오로 많음, 불안, 갈증, 소변 적음	
	청열해독, 랑혈화어	청영탕, 은화해독탕
혈어발열	오한발열, 오로 간헐적, 혈괴, 소복통, 건조, 변비	
	활혈거어, 청열해독	생화탕, 도홍소어탕
외감발열	오한발열, 두통, 기침	
	[풍한] 양혈거풍해표	형방사물탕
	[풍열] 신량해표, 소풍청열	은교산
혈허발열	미열, 오후에 발열, 발한, 오로 적음, 창백, 현훈, 목현, 경계, 정충	
	보혈익기, 양음청열	성유탕, 가감일음전

※ 산후발열치료에 있어서 항생제 (참고)

- 감염사독형은 산후발열의 중증이므로 필요에 따라 항생제 투여 고려
- 중증 감염이거나 제왕절개술 후 감염은 투여가 필수적임.
- 다만, 항생제 사용에 따른 부작용을 고려하여야 함.
- 클린다마이신의 경우 위막성 대장염을 일으킬 수 있음

3장 산후 신경계 및 정신 관련 병증

- 임신, 산욕기는 정신질환 일으키기에 충분한 스트레스
- 기존 정신질환 호전 또는 악화되거나 새로운 정신질환 발생
- 생화학적 요인 + 정신적 스트레스 가 발생

산후우울기분장애 (50%)	
시기	분만 3~6일에 발생 (프로게스테론 소퇴와 연관)
증상	불면, 걱정, 불안, 집중력저하, 과민성, 짜증 → 증상경미, 수일 내 소실
치료	안정, 정신질환예방을 위한 관찰
산후우울증 (산욕기 : 8~15%, 성인여성 : 30%)	
시기	분만 3~6개월에 발생
특징	이미 우울증이 있었거나 청춘기 산모에서 더 잘 발생
예후	다음 임신에 재발(70%), 6개월에 걸쳐 서서히 좋아지는 것이 보통
치료	보조적 요법으로는 불충분해 약물치료 필요
산후정신병 (1000명 당 1~4명)	
정의	출산과 시간적 연관성을 가진 망상과 극심한 우울증을 동반하는 정신병
원인	의미있는 양극성 장애, 정신분열증, 출산시 감염, 약물, 임신중독, 출혈, 정신적인 부부갈등
시기	출산 2-3주 후 (출산후 3일째 증상 시작)
위험요인	초산부, 젊은 나이, 정신병의 가족력
예후가 좋은 경우	병전 성격이 좋은 경우, 정신분열증이나 우울증이 없을 때, 가족들이 지지가 있을 때
치료	응급으로 시행, 대개 입원 필요, 약물치료 필요

1절 산후경증

= 산후경련발작 = 산후경풍 = 산후발경 = 산후경병

1. 개술

정의	분만 직후나 산욕기에 산모가 수족추축하고 항배강직 심하면 구금(口噤)하고 각궁반장하는 경우	
특징	- 산후삼병 중 하나 - 산후파상풍 : 산후의 창상(創傷)에 사독이 감염되어 發瘕 - 음혈허로 인한 發瘕 = postpartum tetany와 유사	
병인병기	- 산후 망혈상진으로 심간혈허, 근육실양 (虛) → 창상에 사독 침입 - 산후파상풍 : 분만 시 생긴 창상에 파상풍균 감염, 척수/연수 침입	
진단	임상증상	사지경련, 뒷목과 등의 강직, 의식소실, 각궁반장
	감별진단	산후자간, 산후전간발작, 산후고열추축, 산후중풍
예방과 조리	- 급한 분만·난산&산도감염/손상 이 있으면 철저히 치료 - 12시간 지나 파상풍 예방주사(TAT) - 빛 약한 병실에 격리, 외부의 자극을 피하게 해 구강청결에 주의	

2. 변증치료

음혈휴허	산후 실혈 과다, 한출, 추축항강, 면색창백, 위황	
	육음양혈, 유간식풍	三甲復脈湯, 滋營活絡湯
	예후	경증 → 치료 후 거의 완치
사독감염	오한발열, 경항강, 추축고소, 항배강직	
	진경, 이기거풍	玉眞散, 獨蓼湯, 撮風散
	예후	중증 → 사망률 높고 예후 불량

2절 산후탄탄

1. 개술

정의	산후에 반신불수가 생기고 수족 마목불인, 구련, 통증을 느끼지 못 하는 경우 [금궤요략] 血痺陰陽俱未, 寸口關上微, 尺中小緊, 外證身體不仁, 如風痺狀, 黃芪桂枝五物湯主
병인병기	- 手足癱瘓 : 혈허로 발생 - 분만시 실혈과다 → 경맥공허 → 근맥기육 실양 → 마목불인

2. 변증치료

혈허	수족마비, 감각없음, 떨림, 현훈, 경계	
	보기양혈, 좌이통락	황기계지오물탕 가 당귀 계혈

3절 산후 정신이상

- 임신 및 분만 자체가 특정 정신질환과 관련있지는 않음
- 다만, 분만 전후에 이르면 정신질환이 발생할 가능성이 커짐

1. 개술

정의	산후에 정신황홀, 망언발광, 언어전도(言語顛倒), 이노선곡(易怒善哭), 희소(善笑)하는 정신이상증상이 나타남	
빈도	- 분만 후 3~7일에 주로 발생 - 80% 이상이 산후 4주 내에 발병	
발병기전	- 산후 실혈모기, 영혈부족 - 산후에 어혈이 불하하고 패혈이 상충 - 산후에 憂思로 傷脾하여 담탁이 자생하고 심규요란(心竅擾亂)	
감별진단	① 백합병(百合病)	정서불안, 욕구불만, 정신혼란
	② 장조(臟躁)	울고나면 마음이 조금 편해지며 신지가 명료

2. 변증치료

심기허약	경계정충, 불안, 정서억압, 열감, 불면, 우울, 현훈, 건망, 피로, 식욕부진	
	익기보혈, 양심안신	滋營益氣茯神湯
심음휴손	근심걱정, 두려움, 정신혼란, 건망, 불면, 수족장열, 건조, 도한, 대변건	
	자음안신	二陰煎 + 석창포, 용골, 모려
어혈승심	정신혼란, 광기, 불안, 소복통, 어혈 배출 잘 안 됨	
	행기활혈, 냉심안신	안신생화탕 + 울금 석창포
담화상요	화 잘 냄, 광기, 불안, 물건 훼손, 불면, 두통, 면적	
	척담사화, 진심안신	生鐵落飲

5장 산후 소화기계 관련 병증

1절 산후 대변난

1. 개술

정의	- 산후에 대변이 곤란하거나 수일간 배변하지 못하거나 대변이 건조하고 동통해 배변이 힘든 경우
치료	- 양혈윤장이 주 - 기혈편허의 정도 혹은 내열이나 양명부실을 겸함에 따라 결정
예방과 조리	- 산후의 출혈과 발한으로 인한 진액 손상을 예방 - 초기에 일어나 적당한 활동으로 장운동 촉진 - 과일과 야채를 많이 복용하여 장의 연동운동 도움 - 맵고 짠 자극성 음식을 피하며 깨죽 복용 - 규칙적인 배변 습관을 기르는 것

2. 변증치료

혈허진후	대변건조, 배변곤란, 피부건조, 얼굴 누렇다, 현훈, 경계정충	
	양혈윤조	사물탕, 마자인환, 자장오인환, 양정통유탕
기허실운	배변곤란, 숨 가쁨, 식은땀, 배변 후 피로	
	익기윤장	황기탕, 윤조탕, 성유탕
양명부실	대변곤란, 미열, 구취, 복부창만	
	통부사열, 겸이양혈	옥축산

2절 산후설사

1. 개술

정의	- 산후에 배변횟수가 증가하고 분변이 희당하며 심하면 수양변을 봄
산후설사의 영향	- 진액의 대량유실 뿐만 아니라 정혈손상 초래하여 산후복원 어려움 - 유즙생성에도 영향을 미쳐 유즙 적어지거나 결유(缺乳) - 적절하게 치료하지 못하면 액탈혼궤증(液脫昏厥證)
병인병기	[한방] 脾虛濕盛, 寒濕, 濕熱, 食傷, 腎虛 [현대의학] 산욕기장염, 분만과정 중 자극, 장관 혈액순환장애, 미주신경 기능문란으로 장관 연동운동이 촉진되어 발생

2. 변증치료

비위허약	소화불량, 식욕부진, 답답, 복부창만, 위황, 피로	
	건비삼습	삼령백출산
한습내성	복명, 복통, 가슴답답, 식욕부진, 오한발열, 신체통	
	산한조습	곽향정기산
습열하주	항문 작열감, 건조, 소변량 감소, 복통 후 설사	
	청열리습	갈근금령탕
식상위장	복통 후 설사, 복부창만, 트림 냄새 고약, 식욕부진	
	소식도체	보화환
신허화쇠	복부 찬 것 싫음, 복부창만, 하지 냉감	
	온신완토, 삼장지사	사신환